



Malang, 22 Januari 2024

Nomor : 067/I-PM/DIR/I/2024
Lampiran : 22 Halaman
Perihal : Permohonan Proses Perjanjian Kerja Sama

Kepada Yth.
Ibu Endang Susilowati
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan proses tindak lanjut perjanjian kerja sama sebagai berikut :

NO	ASAL PKS	JUDUL PKS	KETERANGAN
1.	PT. Global Trans Jaya Mulia PT. BS Jaya PT. Teman Sejati Sejahtera	Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3	Perpanjangan PKS : 1. PT. Global Trans Jaya Mulia dan PT BS. Jaya : Expired 31 Maret 2024 2. PT. Temann Sejati Sejahtera : 3. Expired 05 Februari 202 4. Hasil Notulen Evaluasi terlampir
2.	PT. Asabri (PERSERO)	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta ASABRI Aktif	Update Tarif pada SIMRS (Terlampir)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ekowati . S. K. P., MMRS



LAMPIRAN

TARIF BIAYA PT. ASABRI (PERSERO)

NO	JENIS BIAYA	HARGA
1	Kelas I	Rp 510.000
2	Kelas II	Rp 330.000
3	Kelas III	Rp 240.000
4	Biaya Administrasi Rawat Inap Kelas 1	Rp 335.000
5	Biaya Administrasi Rawat Jalan	Rp 150.000

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASABRI (PERSERO)
DENGAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG
PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF

NOMOR: PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023

NOMOR: 1902/E-PKS/DIR/XII/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (13-12-2023), oleh:

1. **PT ASABRI (Persero)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Khaidir Abdurrahman**, dalam jabatannya selaku **Direktur Hubungan Kelembagaan**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/HK.02/3-AS/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan (27-08-2008) Nomor 16, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diadakan perubahan terakhir dengan akta tanggal lima belas Juli dua ribu dua puluh satu (15-07-2021) Nomor 10, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh dua (07-02-2022) Nomor 5 jo. akta tanggal dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua (26-07-2022) Nomor 62, keduanya dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT ASABRI (Persero), untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **Rumah Sakit Prima Husada**, suatu Rumah Sakit yang didirikan berdasarkan Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 81201150815810001 tanggal 17 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 65153, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ekowati Supartinah Kamandaka Putri, MMRS**, dalam jabatannya sebagai **Direktur**, berdasarkan SK Nomor 037/DPM/I-KEP/DIR/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Prima Husada, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak, serta dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

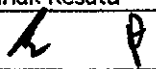
- A. Bahwa Pihak Kesatu adalah Badan Usaha Milik Negara selaku pengelola program yang menyelenggarakan Pembayaran Manfaat Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Fasilitas Kesehatan Lanjutan Rumah Sakit tipe C yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.
- C. Bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada Peserta ASABRI Aktif, Para Pihak sepakat untuk saling melakukan koordinasi dan kerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terkait penanganan Kecelakaan Kerja bagi Peserta ASABRI Aktif yang diselenggarakan oleh Pihak Kesatu dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan Berita Acara Nomor BA-366/YN.10.01/H/XI/2023; 1699/E-BAC/DIR/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta ASABRI Aktif yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja selama masa dinas.
2. Peserta adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Polri yang masih menjalani masa dinas.
3. Pasien JKK adalah Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan mendapatkan perawatan di Faskes.
4. Kecelakaan Kerja adalah kejadian kecelakaan yang dialami Peserta dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, dan kecelakaan di tempat kerja atau tempat lain ketika menjalankan dinas.
5. *Emergency* adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

- promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
7. Surat Jaminan Perawatan yang selanjutnya disingkat SJP adalah surat jaminan pembayaran biaya pelayanan perawatan dan pengobatan Pasien JKK yang dibuat oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.
 8. Obat Generik adalah obat berkhasiat yang namanya sesuai dengan zat aktif yang ada di dalamnya (umumnya berisi zat aktif tunggal) dan dipasarkan dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia.
 9. Kelas Perawatan yang selanjutnya disebut Kelas adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak Pasien JKK sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
 10. Resume Medis adalah ringkasan kegiatan pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter selama perawatan hingga pasien keluar baik dalam keadaan hidup maupun meninggal.
 11. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Faskes.
 12. Buku Tarif Biaya Pelayanan adalah buku yang memuat daftar sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Faskes yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan Pasien JKK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

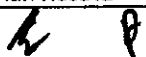
Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:

1. Prosedur pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan.
2. Pembiayaan pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan.
3. Hal-hal yang tidak dijamin.

Pasal 4

PELAYANAN PENGOBATAN DAN PELAYANAN PERAWATAN

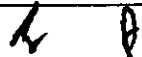
- (1) Pihak Kedua memberikan pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan kepada Pasien JKK sejak diterima di Pihak Kedua (mulai dari mendaftar di poliklinik dan/atau instalasi/unit gawat darurat) sampai sembuh.
- (2) Pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pasien JKK meliputi:
 - a. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. Perawatan dasar tingkat pertama dan lanjutan;

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

- c. Rawat inap Kelas 1;
 - d. Perawatan intensif;
 - e. Penunjang diagnostik;
 - f. Pengobatan;
 - g. Pelayanan khusus;
 - h. Alat kesehatan dan implan;
 - i. Jasa dokter dan/atau medis;
 - j. Operasi;
 - k. Transfusi darah; dan/atau
 - l. Rehabilitasi medik.
- (3) Apabila dalam keadaan *Emergency*, karena keterbatasan kemampuan SDM dan Faskes dari Pihak Kedua Pasien JKK harus ditangani oleh dokter dan/atau Faskes lain, maka Pihak Kedua harus mengeluarkan surat pengantar rujukan sebagai dasar penanganan Pasien JKK.

Pasal 5
PROSEDUR PELAYANAN PENGOBATAN DAN
PELAYANAN PERAWATAN PASIEN JKK

- (1) Pihak Kedua memberikan pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan Program JKK kepada Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Menerima Peserta korban Kecelakaan Kerja dan untuk selanjutnya melakukan identifikasi, tindakan medis, dan segera melaporkan atau menghubungi pihak keluarga dan/atau satuan kerja Peserta untuk dibuatkan surat laporan kejadian Kecelakaan Kerja beserta dokumen pendukung lainnya;
 - b. Mengisi surat keterangan rawat, untuk kemudian dikirimkan ke Pihak Kesatu agar dapat dibuatkan SJP;
 - c. Merujuk Pasien JKK ke Faskes yang lebih tinggi dengan melampirkan surat pengantar rujukan, jika diperlukan penanganan lebih lanjut;
 - d. Menginformasikan secara lisan atau tertulis mengenai perkembangan kondisi Pasien JKK selama dalam perawatan atas permintaan Pihak Kesatu;
 - e. Dokter yang merawat Pasien JKK mengisi Resume Medis jika perawatan dan pengobatan dinyatakan selesai; dan
 - f. Mengajukan klaim biaya pelayanan perawatan secara bertahap atau sekaligus kepada Pihak Kesatu setelah Pasien JKK pulang rawat atau berdasarkan indikasi medis perlu perawatan lanjutan dengan dilampiri berkas Resume Medis dan pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal Pasien JKK harus memperoleh rawat inap, maka Pihak Kedua wajib menyediakan ruang perawatan sesuai dengan hak Pasien JKK tersebut yang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Kedua.
- (3) Pemberian resep obat-obatan oleh Pihak Kedua kepada Pasien JKK mengutamakan Obat Generik yang menyandang logo dalam kemasan (blister/strip).
- (4) Pihak Kedua memberikan pelayanan ambulans untuk Pasien JKK yang memerlukan rujukan ke Faskes lain.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

- (5) Tagihan klaim biaya perawatan diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dengan melampirkan:
- Asli kuitansi biaya perawatan Kecelakaan Kerja bermeterai cukup;
 - Rekapitulasi tagihan dilampirkan rincian biaya perawatan, obat farmasi, dan alat kesehatan;
 - Resume Medis atau keterangan medis;
 - Berkas pendukung lain untuk proses Verifikasi klaim, antara lain foto dan hasil pemeriksaan rontgen sebelum dan setelah tindakan atau operasi pemasangan *orthese/prothese*, hasil pemeriksaan laboratorium, rincian obat, dan bukti pendukung medis lainnya;
 - Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) atau Kartu Peserta ASABRI-Elektronik (KPA-E); dan
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (6) Pihak Kesatu melakukan Verifikasi berkas administrasi tagihan klaim sebagaimana disebutkan pada ayat (5), yang telah dilengkapi bukti atas pelayanan kesehatan, paling lambat 5 hari kerja setelah berkas diterima.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan berkas administrasi sebagaimana disebutkan pada ayat (5), maka Pihak Kesatu pada kesempatan pertama meminta kekurangan berkas administrasi kepada Pihak Kedua.
- (8) Setelah berkas administrasi tagihan klaim dinyatakan lengkap, Pihak Kesatu wajib membayarkan tagihan klaim biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan Pasien JKK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan hasil Verifikasi medis dan Verifikasi substansi.
- (9) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Pihak Kedua tidak melengkapi berkas tagihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Pihak Kesatu mengembalikan berkas tagihan klaim.

Pasal 6

BIAYA PELAYANAN PENGOBATAN DAN PELAYANAN PERAWATAN

- Pihak Kesatu akan memberikan penggantian biaya atas jasa pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan program JKK kepada Pihak Kedua berdasarkan hasil Verifikasi klaim.
- Pihak Kedua memberikan pelayanan kamar rawat inap Kelas 1 kepada Pasien JKK, yang dibebankan biaya kepada Pihak Kesatu dengan besaran sebagaimana pada lampiran Perjanjian ini.
- Dalam hal fasilitas kamar rawat inap Kelas 1 dan Kelas dibawahnya tidak tersedia, Pasien JKK dapat naik Kelas rawat inap dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Atas jasa pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Kesatu dikenakan biaya administrasi rawat inap dan biaya administrasi rawat jalan sebagaimana terlampir pada lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Para Pihak akan melakukan peninjauan kelayakan besarnya tarif sesuai perkembangan biaya pelayanan kesehatan yang berlaku, berdasarkan atas inisiatif Pihak Kedua dan kesepakatan Para Pihak.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

- (6) Selama belum terdapat kesepakatan mengenai tarif baru jasa pelayanan kesehatan, Pihak Kedua tetap melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan kepada Pasien JKK dengan tarif sebelum ada perubahan.
- (7) Apabila terjadi penyimpangan dari pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua, maka segala akibat keuangan yang terjadi akan dibebankan kepada Pihak Kedua melalui pemotongan langsung oleh Pihak Kesatu terhadap pembayaran klaim biaya pelayanan kesehatan yang diajukan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu.
- (8) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi bukti setor melalui transfer kepada rekening Pihak Kedua di Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 368-3040700 atas nama PT. Disa Prima Medika dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

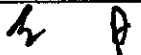
Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan bagi Pasien JKK meliputi:
 - a. Biaya pemeriksaan dan tindakan oleh tenaga medis;
 - b. Biaya pelayanan rawat jalan;
 - c. Biaya rawat inap Kelas 1;
 - d. Biaya operasi;
 - e. Biaya kontrol pasca rawat inap/operasi/*Emergency*;
 - f. Biaya rehabilitasi medis/fisioterapi;
 - g. Biaya pelayanan obat-obatan, alat dan bahan habis pakai, penunjang diagnostik radiologi, penunjang diagnostik laboratorium, dan tindakan khusus sesuai indikasi medis; dan
 - h. Biaya pelayanan ambulans.
- (2) Biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan bagi Pasien JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tentang biaya rehabilitasi berupa penggantian meliputi:
 - a. pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. biaya rehabilitasi medik paling banyak sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - c. biaya penggantian gigi tiruan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kasus.
- (3) Biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan bagi Pasien JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk kepada Buku Tarif Biaya Pelayanan Pihak Kedua.
- (4) Dalam hal Pasien JKK menghendaki pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan di atas standar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka selisih biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan menjadi tanggung jawab Pasien JKK.
- (5) Biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan yang tidak terkait langsung dengan Kecelakaan Kerja, ditanggung oleh Pasien JKK atau instansi terkait lainnya.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 8
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban Pihak Kesatu:
- a. Mematuhi peraturan perawatan yang berlaku di Faskes Pihak Kedua selama sesuai indikasi medis;
 - b. Membuat SJP bagi Pasien JKK yang dirawat di Faskes Pihak Kedua setelah teridentifikasi Kecelakaan Kerja; dan
 - c. Membayar tagihan yang dikirimkan Pihak Kedua setelah dilakukan Verifikasi berkas pengajuan klaim lengkap.
- (2) Kewajiban Pihak Kedua:
- a. Memberikan pelayanan perawatan dan pelayanan pengobatan serta fasilitas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Pasien JKK;
 - b. Membuat surat keterangan rawat berdasarkan surat laporan kejadian Kecelakaan Kerja dari satuan kerja;
 - c. Memberikan informasi dan laporan medis pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien JKK;
 - d. Bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut hasil pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien JKK;
 - e. Memberitahukan kepada Pihak Kesatu setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besarnya biaya perawatan dan pengobatan; dan
 - f. Memberikan Buku Tarif Biaya Pelayanan kepada Pihak Kesatu.
- (3) Hak Pihak Kesatu:
- a. Menerima surat keterangan rawat dari Pihak Kedua;
 - b. Mengawasi tata laksana pelayanan perawatan Pasien JKK yang diberikan oleh Pihak Kedua, agar memenuhi persyaratan indikasi medis yang telah ditentukan;
 - c. Menerima laporan medis pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien JKK;
 - d. Menerima berkas tagihan pelayanan perawatan dari Pihak Kedua;
 - e. Mengembalikan tagihan klaim Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak dapat melengkapi kekurangan berkas tagihan klaim; dan
 - f. Menerima Buku Tarif Biaya Pelayanan dari Pihak Kedua.
- (4) Hak Pihak Kedua:
- a. Melakukan perawatan Pasien JKK sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di Pihak Kedua;
 - b. Menerima SJP dari Pihak Kesatu terhadap pasien yang teridentifikasi akibat Kecelakaan Kerja dan dirawat di Faskes Pihak Kedua; dan
 - c. Menerima pembayaran tagihan dari Pihak Kesatu atas pelayanan pengobatan dan perawatan Pasien JKK.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 9

HAL-HAL YANG TIDAK DIJAMIN PIHAK KESATU

Pihak Kesatu tidak menanggung biaya pelayanan pengobatan dan perawatan untuk kasus-kasus tersebut di bawah ini:

1. Penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup Kecelakaan Kerja;
2. *General check up/check up/regular check up*;
3. Kecelakaan Kerja akibat bencana alam, dampak peperangan, atau dampak lainnya;
4. Cedera dan/atau penyakit akibat perkelahian atau tindakan atasan di luar batas kepatutan;
5. Cedera dan/atau penyakit yang dialami peserta sebagai akibat tindakan atasan atau bawahan yang tidak dalam hubungan kerja;
6. Pengobatan dan perawatan di luar negeri;
7. Gangguan kesehatan/penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotika;
8. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
9. Pengobatan komplementer, alternatif, tradisional dan/atau dampak pengobatan tersebut;
10. Semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus Kecelakaan Kerja;
11. Semua obat kosmetik, jamu-jamuan, obat herbal, obat gosok seperti minyak kayu putih, dan sejenisnya;
12. Operasi plastik dengan tujuan kosmetik;
13. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi;
14. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kegiatan yang bukan berhubungan dengan kedinasan;
15. Kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja, tidak langsung dibawa ke Faskes;
16. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, atau hari libur lainnya dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
17. Kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran hukum, khususnya kecelakaan lalu lintas yang dialami Peserta saat mengemudikan kendaraan, termasuk namun tidak terbatas pada tidak memiliki surat izin mengemudi sesuai golongan kendaraan yang digunakan, atau tidak menggunakan standar keselamatan yang diwajibkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Pemeriksaan penunjang, pengobatan, dan perlengkapan perlindungan diri yang berhubungan dengan *covid-19*, termasuk namun tidak terbatas pada tes Antigen, PCR-swab, pemeriksaan laboratorium, dan/atau rontgen; dan
19. Perawatan dan pemakaman jenazah yaitu biaya pengadaan peti jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya upacara pemakaman jenazah dan biaya perawatan jenazah yang bersumber dari pagu indeks Kementerian Pertahanan dan/atau pagu indeks Yanma Polri/Polda, yang pengajuannya dapat diajukan kepada unit organisasi Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan/atau Yanma Polri pada tingkat Mabes Polri dan/atau Yanma Polda pada tingkat Polda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 10
KEDALUWARSA KLAIM

Pengajuan klaim kedaluwarsa jika diajukan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Pasien JKK selesai menjalani perawatan dan pengobatan pada Faskes Pihak Kedua.

Pasal 11
WANPRESTASI DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak lainnya berhak mengirimkan surat pemberitahuan dan selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi surat peringatan kepada Pihak yang melakukan wanprestasi agar memenuhi kewajibannya.
- (2) Apabila salah satu Pihak yang melakukan wanprestasi sudah menerima surat pemberitahuan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1), namun tidak melakukan perbaikan dan tidak memberikan laporan atas hasil perbaikan dimaksud, maka Pihak lainnya memberikan surat peringatan kepada Pihak yang melakukan wanprestasi.
- (3) Apabila setelah surat peringatan dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Pihak yang melakukan wanprestasi tetap tidak melakukan perbaikan dan tidak memberikan laporan dan/atau konfirmasi atas hasil perbaikan dimaksud, setelah menerima surat peringatan pertama dan/atau surat peringatan kedua pemberian layanan proses klaim atau pemberian pelayanan kesehatan akan diberhentikan sementara.
- (4) Dalam hal Pihak yang melakukan wanprestasi telah melaksanakan perbaikan dan memberikan laporan dan/atau konfirmasi sebagaimana dimaksud oleh Pihak Lainnya, maka pemberhentian sementara dicabut, akan tetapi apabila Pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan evaluasi Pihak lainnya tidak melaksanakan perbaikan dan tidak memberikan laporan dan/atau konfirmasi, maka dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan ketiga.
- (5) Apabila setelah surat peringatan dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Pihak yang melakukan wanprestasi tetap tidak melakukan perbaikan dan tidak memberikan laporan dan/atau konfirmasi atas hasil perbaikan dimaksud selama 3 (tiga) bulan, setelah diterbitkan surat peringatan ketiga, maka Pihak lainnya dapat melakukan pengakhiran Perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 12
SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN

- (1) Para Pihak mengadakan sosialisasi dan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Biaya yang timbul atas pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan ditanggung oleh Pihak yang menginisiasi.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf	 	

Pasal 13
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2026.

Pasal 14
ADENDUM

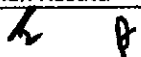
Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas isi Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu Pihak, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (3) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Para Pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan atau pemutusan perjanjian, sepanjang mengatur mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 16
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu Pihak menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan.
- (3) Apabila Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

Pasal 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Para Pihak merupakan badan hukum yang sah didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berwenang untuk mengadakan serta melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan Pihak yang berwenang dan/atau memiliki kuasa untuk mewakili atas nama masing-masing Pihak.
 - c. Para Pihak mempunyai semua perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan dalam hal diperlukan maka akan disampaikan kepada Pihak lainnya.
- (2) Pihak Kesatu menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Pihak Kesatu akan menjaga Resume Medis atau keterangan medis atau informasi medis lain Pasien JKK yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua.
 - b. Pihak Kesatu telah memiliki otorisasi atau kuasa penuh dari Pasien JKK untuk memperoleh Resume Medis dari Pihak Kedua.
 - c. Pihak Kedua tidak akan menerima tuntutan dan/atau gugatan dari Pasien JKK dan/atau keluarga Pasien JKK dan/atau pihak lain sehubungan dengan penyerahan Resume Medis kepada Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua tidak akan bertanggung jawab terhadap segala risiko yang timbul dari penyerahan Resume Medis tersebut.

Pasal 18
FORCE MAJEURE

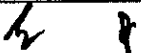
- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan Para Pihak sesuai Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada gangguan teknologi informasi, bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah di bidang ekonomi atau moneter yang bersifat sementara.
- (2) *Force Majeure* harus diberitahukan oleh Pihak yang mengalaminya kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan bukti autentik dan/atau pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan Pihak lainnya.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan, dan setelah *Force Majeure* tersebut berakhir, Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (4) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dengan cara musyawarah.
- (5) Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* lalai dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum pada ayat (2) di atas, maka keterlambatan pelaksanaan kewajiban dari Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut dianggap bukan sebagai akibat dari *Force Majeure*.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf	 	

- (6) Para Pihak dapat membicarakan secara musyawarah dan menyepakati secara tertulis tentang syarat dan kondisi baru yang diberlakukan kepada Para Pihak setelah timbul *Force Majeure* tersebut, dan syarat dan kondisi tersebut akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 19
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, selama dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian dan tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk Informasi Rahasia, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) Akses atas Informasi Rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat Para Pihak meskipun Perjanjian telah berakhir.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku terhadap informasi sebagai berikut:
 - a. Informasi yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas (*public domain*) pada saat Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada Pihak yang menerima Informasi Rahasia, atau yang telah bocor kepada masyarakat luas, kecuali hal itu terjadi karena pelanggaran Pihak yang menerima Informasi Rahasia, namun Informasi Rahasia tidak boleh dianggap telah menjadi pengetahuan publik apabila didasarkan pada kenyataan bahwa Informasi Rahasia telah diketahui oleh sedikit orang yang merupakan atau kemungkinan memiliki kepentingan komersial;
 - b. Informasi yang telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh salah satu Pihak dari Pihak lain dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan Pihak tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Informasi yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing Pihak, sebagaimana dibuktikan dengan bukti tertulis; atau
 - d. Informasi yang diungkapkan karena perintah, putusan atau penetapan pengadilan atau Pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		

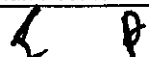
Pasal 20
INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak:

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain direksi/kepala rumah sakit, karyawan, atau pihak terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini; dan
4. Mengikuti ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pasal 21
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak Para Pihak, dengan demikian setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau Perjanjian yang telah dibuat dan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan atau karena keputusan pengadilan diharuskan diberlakukan atau dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian ini tanpa perlu dibuatkan perubahan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan atau karena keputusan pengadilan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat, dan Para Pihak sepakat untuk mengubah syarat-syarat atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum, sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (4) Lampiran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti Perjanjian ini.

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

Pasal 22
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat, atau komunikasi lainnya dari dan untuk Para Pihak ditujukan ke alamat:

Pihak Kesatu: **PT ASABRI (Persero)**

1. Kepala Divisi Layanan

2. Kepala Divisi Keuangan

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630

Telepon : (021) 8094135, 8094140

Faksimile : (021) 8012313

Call Center : 08111622133 / 1500043

E-Mail : divisi.layanan@asabri.co.id; divisi.keuangan@asabri.co.id

Pihak Kedua: **Rumah Sakit Prima Husada**

1. Kepala Keuangan

2. Humas Marketing

Alamat : Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Kecamatan
Singosari, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 65153

Telepon : 0341-458679, 0811 3507 164

Faksimile : 441874

Call Center : 0341-458679

E-Mail : marketingrsphm@gmail.com

keuangan@malang.rs-primahusada.com

- (2) Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Segala akibat keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 23
KETENTUAN PERALIHAN

Apabila Para Pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama, yang dinyatakan dengan bukti tertulis sebelum Perjanjian ini berakhir, namun Perjanjian yang baru belum ditandatangani oleh Para Pihak, maka Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan paling lambat 6 (enam) bulan.

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

Pasal 24
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah diterima oleh Para Pihak setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KESATU,



KHAIDIR ABDURRAHMAN
DIREKTUR HUBUNGAN KELEMBAGAAN

PIHAK KEDUA,



dr. EKOWATI S.K.P., MMRS
DIREKTUR

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	 	

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT ASABRI (PERSERO)
 DENGAN RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
 NOMOR PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
 NOMOR 1902/E-PKS/DIR/XII/2023
 TANGGAL 13 DESEMBER 2023

**TARIF BIAYA
 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

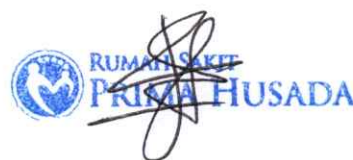
NO	JENIS BIAYA	HARGA
1.	Kelas I	Rp510.000,-
2.	Kelas II	Rp330.000,-
3.	Kelas III	Rp240.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Rawat Inap Kelas 1	Rp355.000,-
5.	Biaya Adminitrasi Rawat Jalan	Rp150.000,-

PIHAK KESATU,



KHAIDIR ABDURRAHMAN
 DIREKTUR HUBUNGAN KELEMBAGAAN

PIHAK KEDUA,



dr. EKOWATI S.K.P, MMRS
 DIREKTUR

	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Paraf		



NOTULEN

Yang dilaksanakan pada : Rabu, 10 Januari 2024
Pukul : 12.17 – 12.45 WIB
Materi : Rapat Evaluasi PKS PT. Kasoem Hearing dan ASABRI
Tempat : Ruang Rapat Kantor 2B

Berikut hasil notulen :

NO.	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Evaluasi PKS Kasoem	1. Update jumlah jaminan BPJS Kesehatan	Update sesuai dengan tarif baru Rp 1.100.000	Keuangan
		2. Perpanjangan PKS ke PT	Bersurat ke PT dan Kasoem : 1) Menambahkan update tarif jaminan dari BPJS Kesehatan Rp 1.100.000 2) Revisi dalam klausul pengiriman invoice h+7 dari pengiriman barang	1. Humas dan Marketing 2. Sekre
2	PKS ASABRI	PKS ASABRI telah selesai Sign dua belah Pihak , PKS telah berlaku	Pembuatan tarif baru sesuai tarif swasta ke PT serta disesuaikan tarif kamar dan administrasinya → membuatkan tarif Asabri	1. Keuangan 2. Sekre 3. Humas dan Marketing

Pemimpin Rapat,
Direktur RS Prima Husada



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

dr. Ekowati. S. K. P., MMRS

Malang, 10 Januari 2024
Notulis,

Mahesa Yudistiranti, S. AP

DOKUMENTASI



NOTULEN

Yang dilaksanakan pada : Rabu, 10 Januari 2024
Pukul : 11.13 – 11.40 WIB
Materi : Rapat Evaluasi PKS Limbah B3
Tempat : Ruang Rapat Kantor 2B

Berikut hasil notulen :

NO.	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	PKS Limbah B3	1. Masa berlaku PKS hampir habis (Feb 2024)	1. Pengajuan perpanjangan KS Baru dengan pembuatan surat pemberitahuan ke Legal PT. DPM 2. Resume dilampirkan untuk pengajuan perpanjangan ke PT	Sekre
		2. PKS sudah berjalan sesuai ketentuan	1. Proses pengangkutan limbah dari RS sudah berjalan sesuai ketentuan yang tertera dalam Perjanjian 2. Petugas dan Transporter selalu memakai APD.	Sekre
		3. Tarif atau biaya yang muncul selama kontrak berjalan	1. Keuangan RS koordinasi dengan Keuangan PT 2. Data pada keuangan RS dan Keuangan PT harus sesuai	Keuangan RS
		4. Draft PKS lama dan baru	Mereview isi PKS yang lama dengan yang baru	1. Humas dan Marketing 2. IPSRS
		5. Hasil review PKS	PKS dapat diperpanjang	Sekre

Pemimpin Rapat,
Direktur RS Prima Husada



dr. Ekowati. S. K. P., MMRS

Malang, 10 Januari 2024

Notulis,



Mahesa Yudistiranti, S. AP



DOKUMENTASI





RSPHMLG
RS PRIMA HUSADA MALANG, SINGOSARI - MALANG
RS PRIMA HUSADA MALANG

Daftar Hadir
Rapat Evaluasi PKS Limbah B3

Tempat : Ruang Meeting 2B
Tanggal dan : Rabu, 2024-01-10 11:00:00
Jam : Wed, 2024-01-10 11:00:00
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM	RS Prima Husada Malang	Admin IPSRS		
2	Mahesa Yudistiranti		administrasi		
3	Nur Lailatul Farida, S.Kep.,Ns	Humas & Marketing	Humas & Marketing		
4	Very Susanto, S.Kep.Ns	RSPHMLG	Kepala Bidang Keperawatan RSPH Malang		
5	dr.Nur Mazidah	RSPHMLG	Kepala Bidang Pelayanan Medik RSPH Malang		
6	Ns. Sherly Rosita, S. Kep.	RS Prima Husada Malang	Perawat IPCN		
7	drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	Manajemen	PESERTA		
8	Putri Indah Purnamasari,AMd.Keb	RSPHMLG	PLT Kepala Bidang Penunjang Medik RSPH Malang		
9	Fuat Krisnanto	DPM	Supervisor IPSRS PT. Disa Prima Medika		

Malang, 20 Januari 2024

dr. Ekowati. S. K. P., MMRS